

INTRODUCTION

Contexte

L'hygiène hospitalière est un pilier fondamental de la sécurité des soins, essentielle pour prévenir les infections nosocomiales et protéger la santé publique. Au cœur de cette problématique se trouve la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI). D'un point de vue conceptuel, l'hygiène environnementale des hôpitaux englobe plusieurs domaines techniques indispensables, notamment la désinfection des surfaces, le contrôle de l'air et de l'eau, et la gestion des déchets. La littérature démontre une corrélation directe entre l'efficacité de la gestion des déchets et le maintien de la propreté clinique : l'accumulation ou la mauvaise manipulation des déchets hautement infectieux favorise la prolifération de micro-organismes pathogènes (tels que Staphylococcus aureus et E. coli), menaçant la sécurité des patients et du personnel.

À l'échelle internationale, la gestion des déchets médicaux révèle d'importantes disparités. Alors que les pays développés appliquent des réglementations strictes en matière de tri et de traçabilité, les pays en développement se heurtent à de fortes contraintes budgétaires, logistiques et humaines. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 75% à 90% des déchets générés par les établissements de santé sont non dangereux, tandis que les 10% à 25% restants constituent des déchets à risques qui exigent un prétraitement avant élimination.

Le CHU Ibn Badis de Constantine est l'un des plus grands centres hospitaliers d'Algérie, abritant plus de 1400 lits et employant plus de 3500 agents. Il dessert 17 wilayas de l'Est algérien et génère environ 471,77 tonnes par an de déchets médicaux infectieux, le classant au 3ème rang national en termes de production de déchets hospitaliers.

Problématique de recherche

Dans quelle mesure les pratiques actuelles de gestion des déchets au CHU Ibn Badis affectent-elles les standards d'hygiène hospitalière, et comment s'inscrire dans une perspective de durabilité globale (environnementale, économique et sociale) ?

Objectifs de l'étude (Objectifs de la Recherche)

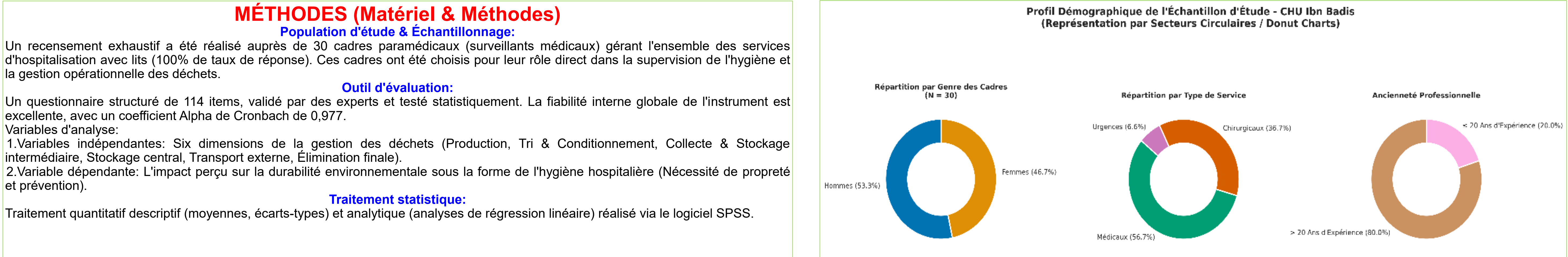
Évaluer l'impact réel du système actuel de gestion des déchets d'activités de soins sur l'hygiène hospitalière (durabilité environnementale) au sein du CHU Ibn Badis, afin de proposer un modèle de transition vers une gestion durable et sécurisée.

Diagnostiquer l'état des lieux opérationnel: Évaluer quantitativement et qualitativement le niveau de mise en œuvre des six étapes clés de la gestion des déchets (Production, Tri, Collecte/Stockage intermédiaire, Stockage central, Transport externe, et Élimination finale) selon les normes réglementaires algériennes.

Mesurer statistiquement l'impact sur l'hygiène: Analyser la corrélation et l'effet causal des défaillances logistiques internes sur la dégradation de la propreté clinique et de la sécurité sanitaire dans les services d'hospitalisation.

Identifier les goulots d'étranglement organisationnels: Repérer les causes profondes des dysfonctionnements à l'aide du diagramme d'Ishikawa (Ies 6M : Milieu, Matériel, Méthodes, Main-d'œuvre, Management, Finances).

Formuler des perspectives de durabilité intégrées: Proposer des solutions concrètes articulées autour des trois piliers du développement durable : environnemental (sécurité biologique), économique (financement circulaire par le recyclage), et social (santé au travail et formation continue).



RÉSULTATS (État des lieux quantitatif)

A. Évaluation par dimension de gestion (Moyennes / 5)

1. Tri & Conditionnement (Moyenne : 3,24): Les services font preuve d'un respect relatif du code couleur réglementaire national. Cependant, l'absence de désinfection systématique des sacs/bacs avant transport vers le stockage (moyenne: 2,56) constitue une faille critique.

2. Transport Externe (Moyenne: 3,20): Présence de signalisations sur les véhicules dédiés, mais traçabilité administrative partielle.

3. Élimination Finale (Moyenne: 3,17): L'enfouissement des pièces anatomiques respecte les rituels religieux/culturels (Moyenne: 3,46), mais il y a une sous-utilisation des techniques de prétraitement (broyage-stérilisation, moyenne: 2,86) avant rejet.

4. Collecte & Stockage Intermédiaire (Moyenne: 3,13): La collecte quotidienne est assurée efficacement (Moyenne: 3,83). Toutefois, les locaux de stockage intermédiaire sont exigus et non adaptés au volume de déchets produit par les services (Moyenne: 2,73), et manquent de matériel de sécurité et d'hygiène (Moyenne: 2,60).

5. Production & Goulots amont (Moyenne: 2,92): Manque de registre d'inventaire et de traçabilité systématique, moyenne: 2,76) et absence d'une politique claire de réduction à la source ou de recyclage de la fraction non dangereuse.

6. Stockage Centralisé (Moyenne: 2,79): Les dépôts centraux ne répondent pas pleinement aux exigences réglementaires de sécurité, de fermeture hermétique et de salubrité (Moyenne: 2,43).

B. Impact perçu sur l'Hygiène Hospitalière

Le score moyen d'impact sur l'hygiène hospitalière (durabilité environnementale) est évalué à 1,66 sur 3 (dans la fourchette de [1,00 - 1,67] indiquant un effet négatif perçu significatif). Les pratiques actuelles (notamment l'exiguïté des stockages temporaires et le manque de désinfection) dégradent l'hygiène générale au sein des services d'hospitalisation.

